

210 Yorumlu Veteriner Klinik Vaka · Bonus

BAŞLARKEN

Sunum sırasında takılıp kalmamak için

Bir vakayı bilmek ile onu bir hocaya, bir klinik ekibe veya bir sınav komisyonuna anlatmak farklı becerilerdir. Çoğu öğrenci bilgiyi bildiği hâlde **sıra kaybettiği için** takılır.

Bu bonus, akademik bir vaka sunumunu düzenlemeniz için hazır yapılar ve şablonlar verir. 210 vakanın her birini bu yapılarla sunarak pratik yapabilirsiniz.

İçindekiler

1. Sunumun iskeleti
2. Anamnez nasıl anlatılır?
3. Problem listesi
4. Hipotezler ve ayırıcı tanılar
5. Tetkikler ve sonuç
6. 5 dakikalık sunum şablonu
7. Örnek sunum: Vaka 014
8. Sorulara hazırlık ve kontrol listesi

BÖLÜM 1

Sunumun iskeleti

Bölüm	Süre	İçerik
1 · Giriş cümlesi	15 sn	Tür, yaş, ırk, cinsiyet + ana şikâyet tek cümlede
2 · Anamnez	45 sn	Ne zaman başladı, nasıl seyretti, öncesinde ne oldu?
3 · Fiziksel muayene	30 sn	Sadece anormal ve ilgili normal bulgular
4 · Problem listesi	30 sn	Öncelik sırasına göre
5 · Ayırıcı tanılar	60 sn	En olası → en tehlikeli; gerekçeleriyle
6 · Tetkikler ve sonuç	60 sn	Hangi test hangi hipotezi doğruladı/dışladı
7 · Tedavi ve izlem	30 sn	Plan, prognoz, sahiple iletişim

Giriş cümlesi kalıbı: «[Yaş] yaşında, [cinsiyet] bir [ırk/tür], [süre]dir devam eden [ana şikâyet] nedeniyle getirildi.»

BÖLÜM 2

Anamnez nasıl anlatılır?

Anamnezi zaman sırasına göre anlatın ve sadece vakayla ilgili bilgileri seçin.

- **Başlangıç ve süre:** ani mi, kademeli mi?
- **Seyir:** kötüleşiyor mu, dalgalı mı?
- **Eşlik eden belirtiler:** iştah, su tüketimi, kusma, ishal, öksürük, davranış.
- **Çevre ve yönetim:** beslenme, aşı ve parazit programı, diğer hayvanlar, seyahat.
- **İlaç ve toksin teması:** son kullanılan ilaçlar, ulaşabildiği maddeler.
- **Önceki hastalıklar ve tedaviye yanıt.**

> Kaçının: Tüm bilgiyi ezberden sıralamak. Dinleyici ilgili bilgiyi sizin seçmenizi bekler.

BÖLÜM 3

Problem listesi

Problem listesi sunumun omurgasıdır. Her anormal bulguyu yazın, sonra ilişkili olanları gruplayın.

Ham bulgular	Gruplanmış problem
Poliüri, polidipsi, düşük idrar dansitesi	PU/PD + izostenüri
Kusma, karın ağrısı, iştahsızlık	Akut gastrointestinal tablo
Ateş, lökositoz, sola kayma	Sistemik inflamasyon

Sunumda problemleri **öncelik sırasıyla** verin: önce hayatı tehdit edenler, sonra en spesifik olanlar.

BÖLÜM 4

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

Her hipotez için bir cümlelik gerekçe verin. Kalıp:

> «[Hipotez] en olası tanıdır, çünkü [lehine bulgu]. Ancak [aleyhine bulgu] nedeniyle [diğer hipotez] de dışlanmalıdır.»

Ayırıcı tanı kurarken

- DAMNIT-V gibi bir kontrol listesi kullanın (Bonus 01).
- 3–5 hipotezle sınırlayın; uzun listeler dikkati dağıtır.
- «Atlanmaması gereken» tehlikeli tanıyı mutlaka belirtin.

BÖLÜM 5

Tetkikler ve sonuç

Tetkikleri bir liste olarak değil, **hipotezlerle ilişkili** olarak sunun:

Tetkik	Sonuç	Hangi hipotez?	Yorum
Hemogram	Trombosit 45 $\times 10^3/\mu L$	Vektörle bulaşan hastalık / ITP	Destekler, ayırt etmez
Seroloji/PCR	E. canis pozitif	Ehrlichiosis	Doğrular

Sonucu tek cümleyle bağlayın: «Bulgular birlikte değerlendirildiğinde en olası tanı ...'dır.»

BÖLÜM 6

5 dakikalık sunum şablonu

Bu sayfayı çoğaltın ve her sunumdan önce doldurun.

Giriş cümlesi

Anamnez (zaman sırasıyla 3–4 madde)

İlgili fiziksel muayene bulguları

Problem listesi (öncelik sırasıyla)

Ayırıcı tanılar ve gerekçeleri

Tetkikler → hangi hipotez?

Sonuç / kesin veya çalışma tanısı

Tedavi, izlem ve prognoz

BÖLÜM 7

Örnek sunum: Vaka 014

Giriş: «4 yaşında erkek bir köpek, birkaç gündür devam eden halsizlik, ateş ve iştahsızlık nedeniyle getirildi.»

Anamnez: Kenelerin sık görüldüğü bir bölgede yaşıyor; antiparaziter koruması düzensiz. Başka bir hastalık öyküsü yok.

Muayene: Ateş 40,2 °C, hafif soluk mukozalar, lenf düğümlerinde büyüme.

Problem listesi: 1) Ateş, 2) trombositopeni, 3) hafif anemi, 4) lenfadenopati, 5) kene teması.

Ayırıcı tanılar: «En olası tanı ehrlichiosistir, çünkü kene teması, ateş ve trombositopeni birliktedir. Ancak anaplazmoz ve babesiyoz benzer tablo yapabilir; enfeksiyonlar dışlanmadan immün trombositopeni düşünülmemelidir.»

Tetkikler: Seroloji ve PCR ile etken belirlenir; eş zamanlı enfeksiyonlar araştırılır.

Plan: Doksisiklin, destekleyici tedavi, trombosit takibi ve düzenli kene koruması.

BÖLÜM 8

Sorulara hazırlık ve kontrol listesi

Hocaların sık sorduğu sorular

- «Bu bulgu olmasaydı tanınız değişir miydi?»
- «İlk hangi tetkiki isterdiniz ve neden?»
- «En tehlikeli ayırıcı tanı hangisi?»
- «Sahibe prognozu nasıl anlatırsınız?»
- «Tedaviye yanıt vermezse ne yaparsınız?»

Sunum öncesi kontrol listesi

☐ Giriş cümlem tek cümle ve net.

☐ Anamnezi zaman sırasıyla anlatıyorum.

☐ Sadece ilgili muayene bulgularını veriyorum.

☐ Problem listem öncelik sırasında.

☐ Her hipotezin bir gerekçesi var.

☐ Tetkikleri hipotezlerle bağlıyorum.

☐ Sonucu tek cümleyle özetliyorum.

☐ Sunumu yüksek sesle en az bir kez prova ettim.

Sonraki adım: Bu hafta çalıştığınız vakalardan birini seçin, 5 dakikalık şablonu doldurun ve yüksek sesle sunun.